

ESQUIZOFRENIA

Guía de información para pacientes y familiares

¿QUÉ ES LA ESQUIZOFRENIA?

La esquizofrenia es una enfermedad médica que afecta la forma en que una persona piensa, percibe y se comporta. No es una debilidad personal ni el resultado de una mala crianza — es una condición causada por cambios en el funcionamiento del cerebro.

- La esquizofrenia es tratable — muchas personas mejoran significativamente.
- No significa tener "personalidad dividida".
- Las personas con esquizofrenia no son más violentas que la población general.
- El diagnóstico no define quién es usted como persona.

SÍNTOMAS

SÍNTOMAS POSITIVOS (se añaden)	SÍNTOMAS NEGATIVOS (disminuyen)	SÍNTOMAS COGNITIVOS
Alucinaciones (voces, visiones), delirios (creencias falsas), pensamiento desorganizado.	Reducción de la expresividad emocional, del habla espontánea, del interés social y de la motivación.	Dificultades de atención, memoria y concentración. Lentitud para procesar información.

TRATAMIENTO

La esquizofrenia se trata con medicación antipsicótica y apoyo psicosocial. El tratamiento combinado ofrece los mejores resultados.

Medicación antipsicótica

- Es la base del tratamiento — reduce los síntomas positivos (alucinaciones, delirios) y previene recaídas.
- Los medicamentos pueden tardar varias semanas en hacer efecto completo.
- Es fundamental tomarlos de forma continua, incluso cuando se sienta bien.
- Si experimenta efectos secundarios, hable con su médico — hay opciones para manejarlos.
- Existen presentaciones inyectables de acción prolongada para quienes tienen dificultad con las pastillas diarias.

Apoyo psicosocial

- La psicoterapia, las intervenciones familiares y el apoyo en la rehabilitación complementan la medicación.
- La participación de la familia en el tratamiento es uno de los factores más importantes para prevenir recaídas.
- Mantener una rutina, el ejercicio regular y el contacto social mejoran la calidad de vida.

SEÑALES DE ADVERTENCIA DE RECAÍDA

Reconocerlas a tiempo permite actuar antes de que aparezca una crisis. Suelen presentarse días o semanas antes de una recaída completa.

Señales frecuentes	Qué hacer
• Cambios en el sueño (mucho más o menos) • Aumento de la ansiedad o irritabilidad • Aislamiento social o descuido de la higiene • Reaparición de voces o pensamientos inusuales • Dejar de tomar la medicación • Aumento del consumo de alcohol o drogas	• Contacte a su equipo de salud mental lo antes posible. • Asegúrese de estar tomando la medicación correctamente. • Reduzca el estrés y descanse lo suficiente. • Evite el alcohol y las drogas. • Hable con una persona de confianza.

PARA FAMILIARES Y CUIDADORES

Su apoyo es fundamental • Infórmese sobre la enfermedad y el tratamiento. • Aprenda a reconocer las señales de recaída. • Mantenga una comunicación calmada y respetuosa. • Cuide también su propia salud y bienestar. • Busque apoyo cuando lo necesite.	Evite • La crítica excesiva o la hostilidad. • La sobreprotección — fomente la autonomía. • Restar importancia a los síntomas. • Dejar de lado su propia vida por el cuidado.
--	---



Busque ayuda urgente si:

- Aparecen pensamientos de hacerse daño o de suicidarse.
- Hay pensamientos de hacer daño a otras personas.
- Se produce un empeoramiento severo y brusco de los síntomas.
- La persona no puede cuidar de sí misma.

Línea de Atención a la Conducta Suicida (Ministerio de Sanidad)	024
Urgencias / Psiquiatría de guardia (cualquier hospital público)	112